BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHẬT TÂN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /BC-BVNT	*An Giang, ngày tháng 10 năm 2026*

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện công tác quản lý sự cố y khoa
từ ngày 01/01/2026 đến ngày 30/9/2026

Kính gửi: Sở Y tế An Giang (Phòng Nghiệp vụ Y).

Thực hiện Công văn số 7738/SYT-NVY ngày 05/10/2026 của Sở Y tế An Giang về việc tăng cường báo cáo, phòng ngừa sự cố y khoa tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; căn cứ Thông tư số 43/2018/TT-BYT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn phòng ngừa sự cố y khoa trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Bệnh viện Đa khoa Nhật Tân báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý sự cố y khoa từ ngày 01/01/2026 đến ngày 30/9/2026 như sau:

I. SỐ LIỆU SỰ CỐ Y KHOA

Trong kỳ báo cáo, bệnh viện tiếp nhận 38 báo cáo sự cố y khoa qua kênh báo cáo nội bộ (phiếu báo cáo trực tuyến). 38/38 sự cố đã được xử lý và đóng hồ sơ. Phân bố theo quý: quý 1: 8; quý 2: 17; quý 3: 13.

Bảng 1. Sự cố theo hình thức báo cáo

STT	Hình thức báo cáo	Số sự cố	Tỷ lệ
1	Tự nguyện	32	84,2%
2	Bắt buộc	6	15,8%
	Tổng cộng	**38**	

Bảng 2. Sự cố theo mức độ tổn thương (Phụ lục I, Thông tư 43/2018/TT-BYT)

STT	Mức độ tổn thương	Số sự cố	Tỷ lệ
1	NC0 – Chưa gây tổn thương	8	21,1%
2	NC1 – Tổn thương nhẹ	19	50,0%
3	NC2 – Tổn thương trung bình	5	13,2%
4	NC3 – Tổn thương nặng	6	15,8%
	Tổng cộng	**38**	

Có 6 sự cố được đánh giá ở mức tổn thương nặng (NC3) thuộc diện báo cáo bắt buộc, gồm: toa thuốc chẩn đoán và điều trị sai tại phòng khám hô hấp (Truyền Nhiễm, 23/02); nhiều lượt khám hô hấp liên tiếp qua các bác sĩ khác nhau, chưa thống nhất chẩn đoán (Truyền Nhiễm, 23/02); toa thuốc chẩn đoán, điều trị sai và chưa xóa mã chẩn đoán cũ tại phòng khám hô hấp (Truyền Nhiễm, 23/02); sàng lọc mức độ nặng chưa đầy đủ ở người bệnh ngoại kiều, giao tiếp khó khăn (Khám bệnh, 28/03); chậm trình bác sĩ đọc điện tim, phát hiện nhồi máu cơ tim muộn (Nội Tổng quát, 21/04); chỉ

định cận lâm sàng chưa phù hợp trên người bệnh suy tim, chậm xử trí khi SpO2 giảm (Nội Tổng quát, 23/07).

II. KẾT QUẢ PHÂN LOẠI, PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN

Các sự cố được phân loại theo 03 tiêu chí tại Điều 7 Thông tư số 43/2018/TT-BYT: mức độ tổn thương (Bảng 2), nhóm sự cố và nhóm nguyên nhân (Bảng 3, Bảng 4). Danh sách chi tiết từng sự cố kèm theo tại Biểu tổng hợp.

Bảng 3. Sự cố theo nhóm sự cố (Phụ lục IV)

STT	Nhóm sự cố	Số sự cố	Tỷ lệ
1	1. Thực hiện quy trình kỹ thuật, thủ thuật chuyên môn	20	52,6%
2	3. Thuốc và dịch truyền	6	15,8%
3	5. Thiết bị y tế	1	2,6%
4	8. Hạ tầng cơ sở	2	5,3%
5	9. Quản lý nguồn lực, tổ chức	1	2,6%
6	10. Hồ sơ, tài liệu, thủ tục hành chính	8	21,1%
	Tổng cộng	**38**	

Bảng 4. Sự cố theo nhóm nguyên nhân (Phụ lục IV; một sự cố có thể có nhiều nguyên nhân)

STT	Nhóm nguyên nhân	Số sự cố	Tỷ lệ
1	1. Nhân viên	30	78,9%
2	2. Người bệnh	2	5,3%
3	3. Môi trường làm việc	4	10,5%
4	4. Tổ chức/dịch vụ	12	31,6%
5	5. Yếu tố bên ngoài	1	2,6%

Bảng 5. Sự cố theo khoa, phòng

STT	Khoa, phòng	Số sự cố	Tỷ lệ
1	Khám bệnh	10	26,3%
2	Nội Tổng quát	10	26,3%
3	Truyền Nhiễm	6	15,8%
4	Phòng Công tác xã hội	3	7,9%
5	Cấp cứu - Hồi sức tích cực & Chống độc	2	5,3%
6	Liên Chuyên khoa	2	5,3%
7	Nhi	2	5,3%
8	PT - GMHS	1	2,6%
9	Ngoại Tổng quát	1	2,6%
10	Dược	1	2,6%
	Tổng cộng	**38**	

Nhận xét:

- Nhóm sự cố nhiều nhất là thực hiện quy trình kỹ thuật, chuyên môn (20/38), chủ yếu ở khâu tiếp nhận, nhận định ban đầu, chỉ định cận lâm sàng và chỉ định nhập khoa tại Khoa Khám bệnh và Khoa Nội Tổng quát; phần lớn các sự cố NC2, NC3

thuộc nhóm này (chậm báo bác sĩ đọc điện tim, không kiểm tra kết quả điện tim, sàng lọc mức độ nặng chưa đầy đủ).

- Nhóm hồ sơ, tài liệu, thủ tục hành chính (8/38) gồm nhập sai thông tin hành chính, nhận diện người bệnh, đăng ký nhầm phòng khám, nhầm chỉ định xét nghiệm có tên gần giống nhau và sai sót khi báo dịch.

- Nhóm thuốc và dịch truyền (6/38) gồm nhầm thuốc giữa hai người bệnh, phát thuốc hết hạn sử dụng, sử dụng nhiều thuốc chưa cần thiết và 01 trường hợp trẻ tím tái, khó thở sau tiêm thuốc theo y lệnh miệng. Trường hợp này đang được đánh giá lại để phân biệt phản ứng có hại của thuốc với sai sót trong chỉ định, thực hiện thuốc theo hướng dẫn của Công văn 7738/SYT-NVY.

- Nguyên nhân chủ yếu thuộc về nhân viên (thực hành chưa đúng quy định, nhận thức, giao tiếp) và tổ chức (tuân thủ quy trình, phối hợp làm việc nhóm); một số sự cố do cơ sở vật chất, trang thiết bị (bàn mổ hỏng, thiếu tay vịn nhà vệ sinh, gạch nền bung, thiếu giường bệnh).

- Hạn chế: các sự cố trong kỳ chủ yếu mới ghi nhận xử trí và đề xuất ban đầu, chưa được phân tích nguyên nhân gốc theo mẫu Phụ lục IV; việc phân loại theo nhóm sự cố, nhóm nguyên nhân được bộ phận đầu mối thực hiện hồi cứu khi lập báo cáo này.

III. BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC, PHÒNG NGỪA ĐÃ TRIỂN KHAI

- Xử trí kịp thời từng sự cố: chuyển Khoa Hồi sức tích cực, chuyển viện khi cần; đổi thuốc, chỉ định bổ sung hoặc chỉ định lại xét nghiệm, hoàn trả chi phí cho người bệnh; điều chỉnh thông tin hành chính, bổ sung thông tin báo dịch; ngưng sử dụng và dán biển báo thiết bị hỏng chờ sửa chữa.

- Nhắc lại và yêu cầu thực hiện nghiêm quy trình tiếp nhận người bệnh của điều dưỡng: đo dấu hiệu sinh tồn trước khi trình bác sĩ hoặc chuyển đi cận lâm sàng; đo điện tim xong phải báo bác sĩ đọc ngay; kiểm tra kết quả cận lâm sàng sau khi có y lệnh.

- Nhận diện người bệnh bằng câu hỏi mở (người bệnh, người nhà tự nói họ tên); thực hiện 3 kiểm tra, 5 đối chiếu và "5 đúng" khi dùng thuốc; khai thác tiền sử dị ứng trước khi dùng thuốc.

- Khoa Khám bệnh rà soát quy trình tiếp nhận người bệnh đau ngực, khó thở, mệt nhiều; các trường hợp chưa loại trừ bệnh lý tim mạch, nhiễm trùng nặng, đau bụng cấp được chỉ định nhập Khoa Hồi sức tích cực theo dõi; xem lại phác đồ chẩn đoán, điều trị tại phòng khám hô hấp.

- Kiểm tra kỹ phiếu chỉ định, xác nhận loại xét nghiệm và giá dịch vụ khi có các xét nghiệm tên gần giống nhau; rà soát hạn dùng thuốc tại nhà thuốc bệnh viện; Khoa Dược và các khoa lâm sàng xem xét cắt giảm thuốc điều trị triệu chứng không cần thiết.

- Báo sửa chữa, đề xuất lắp tay vịn nhà vệ sinh phòng tập vật lý trị liệu, xử lý gạch nền hành lang; báo Ban 5S và tổ sửa chữa; hướng dẫn người bệnh đi lối khác trong thời gian chờ sửa chữa.

- Duy trì tiêu chí "Báo cáo sự cố y khoa" trong Sổ đi buồng điều dưỡng; Kế hoạch công tác điều dưỡng năm 2026 có nội dung tập huấn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ và đề án cải tiến chất lượng phòng ngừa té ngã người bệnh.

IV. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC

- Văn hóa báo cáo tự nguyện, không quy kết chưa đồng đều giữa các khoa; một số khoa ít hoặc chưa có báo cáo.

- Phiếu báo cáo nội bộ trước đây chưa có trường phân loại theo nhóm sự cố, nhóm nguyên nhân, chưa ghi thời điểm xảy ra và các bước báo cáo; việc phân tích nguyên nhân gốc và theo dõi biện pháp khắc phục chưa được thực hiện thường xuyên.

- Khối lượng công việc lớn, thiếu nhân lực vào các thời điểm cao điểm; một số trường hợp người bệnh ngoại kiều gặp khó khăn về ngôn ngữ.

V. KIẾN NGHỊ VÀ KẾ HOẠCH THỜI GIAN TỚI

- Bệnh viện đã cập nhật phần mềm quản lý sự cố: phân biệt báo cáo tự nguyện và bắt buộc, phân loại đủ 03 tiêu chí, theo dõi các bước báo cáo bắt buộc (bao gồm báo cáo Sở Y tế), hạn 60 ngày đề xuất giải pháp của nhóm chuyên gia, kế hoạch khắc phục có người chịu trách nhiệm, thời hạn và chỉ số theo dõi; bộ phận đầu mối báo cáo Giám đốc hằng tuần.

- Quý IV/2026: phân tích nguyên nhân gốc hồi cứu các sự cố NC2, NC3 trong kỳ; tổ chức tập huấn Thông tư 43/2018/TT-BYT và Công văn 7738/SYT-NVY, phòng và xử trí phản vệ; phản hồi bài học tại giao ban và phổ biến cho các khoa có nguy cơ tương tự.

- Thực hiện báo cáo định kỳ hằng quý gửi Sở Y tế trước ngày 05 tháng đầu quý sau và báo cáo đột xuất ngay khi có sự cố thuộc diện bắt buộc.

- Đề nghị Sở Y tế tổ chức tập huấn, chia sẻ bài học sự cố y khoa giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh và ban hành biểu mẫu báo cáo thống nhất.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý sự cố y khoa từ ngày 01/01/2026 đến ngày 30/9/2026 của Bệnh viện Đa khoa Nhật Tân, kính gửi Sở Y tế An Giang xem xét./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Phòng QLCL, Phòng ĐD;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

Kèm theo: Biểu tổng hợp sự cố y khoa từ 01/01/2026 đến 30/9/2026 (Bieu_tong_hop_SCYK_01-09_2026.xlsx).